

UNIVERSITE DE CONSTANTINE 3

FACULTE DE MEDECINE

Cours destiné aux étudiants 4^{ème} année de médecine

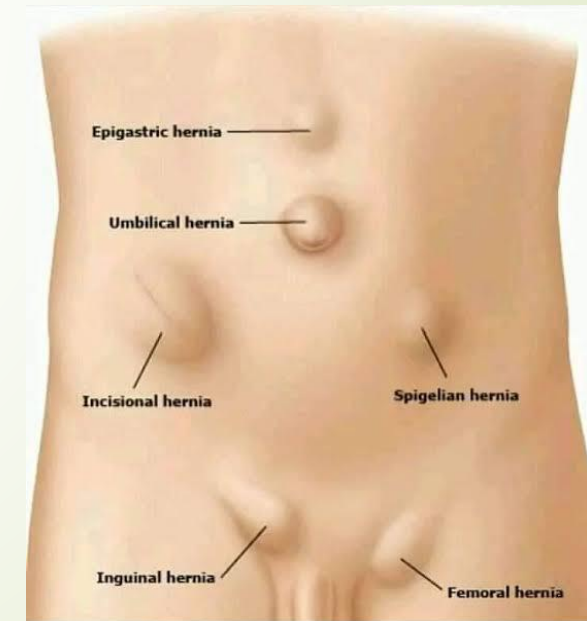
Présenté par Dr S, BENYERBAH

Maitre de conférence (A)

H M R U Constantine

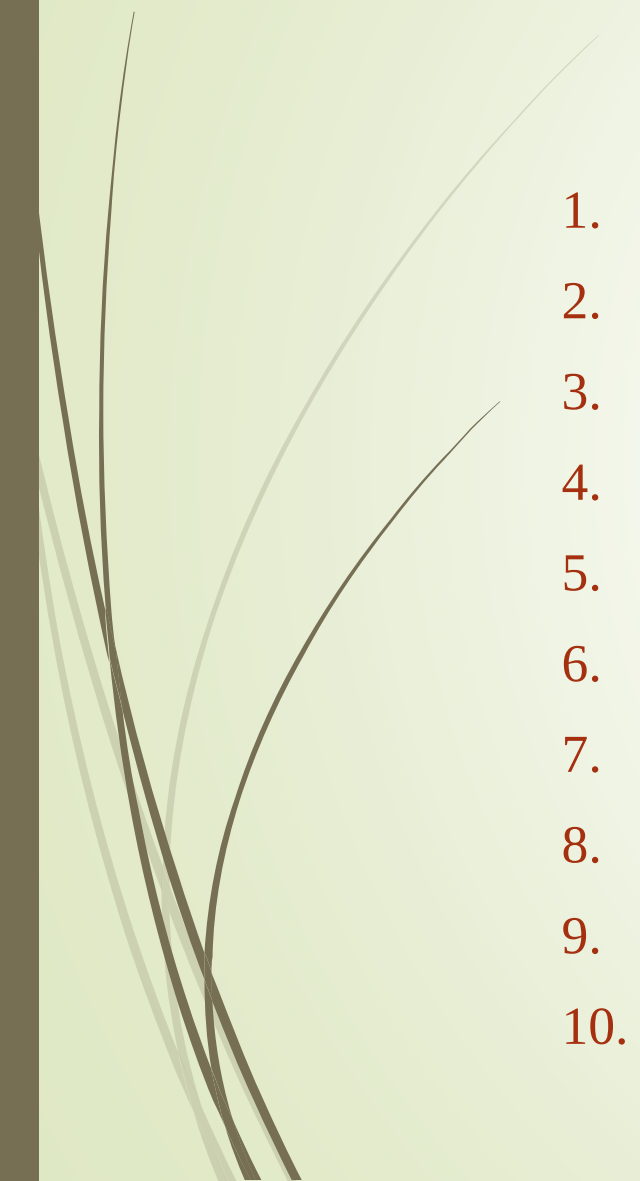
Service de Chirurgie Générale

Année universitaire 2025-2026



HMRUC

PLAN :

- 
- 
1. Introduction
 2. Intérêt de la question
 3. Rappel anatomique
 4. Physiopathologie
 5. Différents types de hernies
 6. Clinique et diagnostic
 7. Diagnostic différentiel
 8. Complications
 9. Traitement
 10. Conclusion

1. Introduction :

- La hernie est l'issue d'un diverticule péritonéal (sac herniaire) pouvant contenir des viscères, à travers un orifice (ou un point faible) naturel de la paroi abdominale représentée essentiellement par la hernie inguinale; et les hernies acquises ou "orificiel" appelées éventration. Toute hernie se définit par un sac péritonéal, communiquant avec la grande cavité par une portion rétrécie appelée « le collet herniaire »; ce sac va s'accroître progressivement en dehors de la cavité abdominale sous l'effet de la pression abdominale .

2. Intérêt de la question :

- Pathologie très fréquente .
- Touche tous les âges et à prédominance masculine (sexe ratio =7,1 pour les hernies de l'aine) .
- Plusieurs localisation topographique.
- Complications morbidités +++
- Diagnostic le plus souvent facile et clinique
- Le traitement est chirurgical .

3. Rappel anatomique :



3. Rappel anatomique :

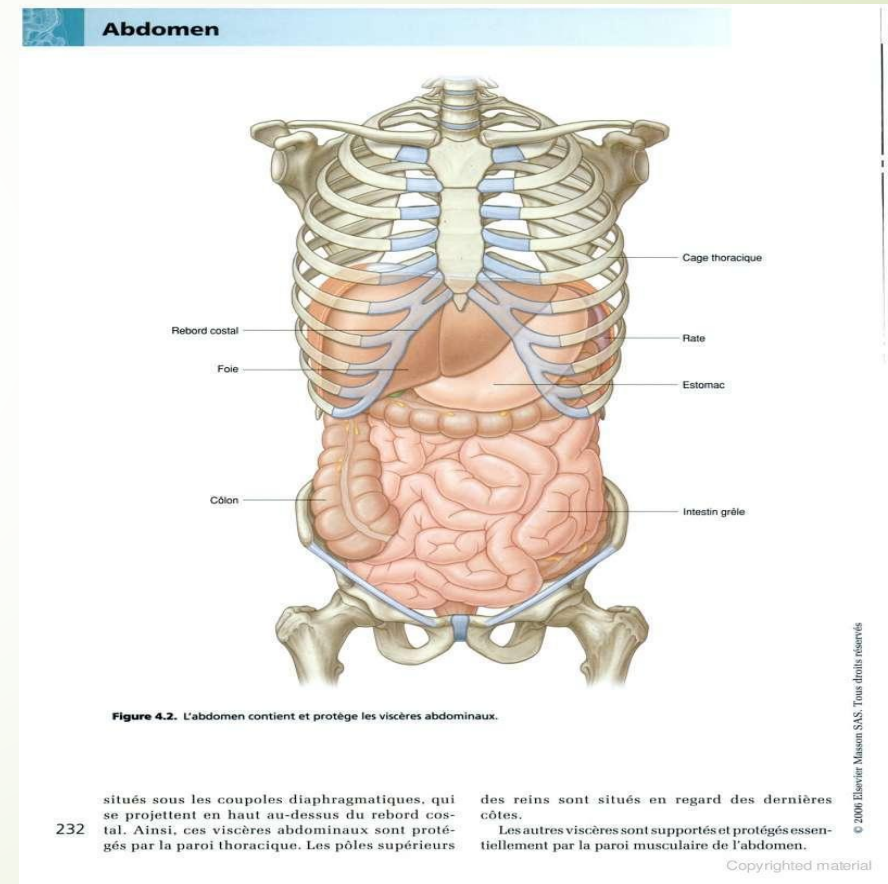
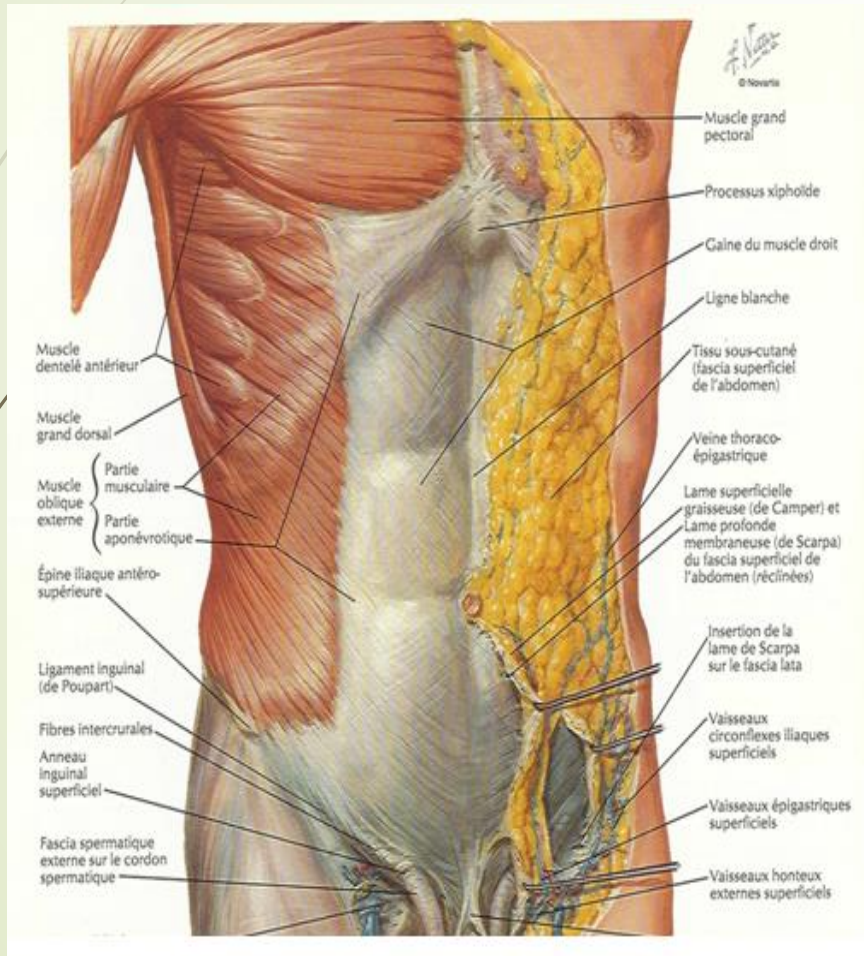
La paroi abdominale antérolatérale est défini par :

- en haut, le rebord thoracique inférieur
- en bas, le bord supérieur de la ceinture pelvienne
- en arrière-, les processus costiformes des vertèbres lombaires.

Dans ce cadre est tendu un système de muscles plats qui s'organisent autour de deux piliers verticaux : les muscles droits de l'abdomen. Ceux-ci sont flanqués des muscles larges, en trois couches, aux directions croisées de la superficie vers la profondeur:

- le muscle oblique externe (grand oblique), dirigé en bas et en dedans;
- le muscle oblique interne (petit oblique), dirigé en haut et en dedans;
- le muscle transverse de l'abdomen aux faisceaux horizontaux.

3. Rappel anatomique :

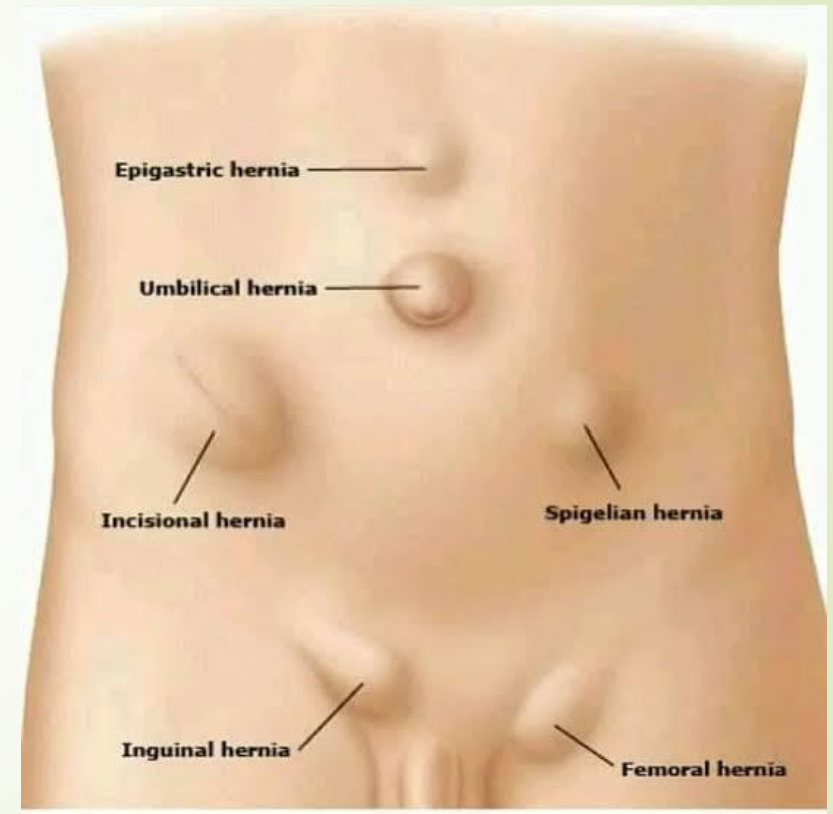


3. Rappel anatomique :

Les aponévroses prolongent ces muscles vers la ligne médiane qui apparaît comme un véritable tendon commun central, percé en son milieu par l'orifice ombilical.

Ces muscles soutiennent les viscères, interviennent dans la respiration, surtout le transverse, à la fois antagoniste et collaborateur du diaphragme.

Des points faibles, situés dans cette paroi (ombilic, ligne blanche médiane, ligne semilunaire de Spiegel) ou à ses limites (région inguino-fémorale, région lombaire), peuvent être le siège de hernies.

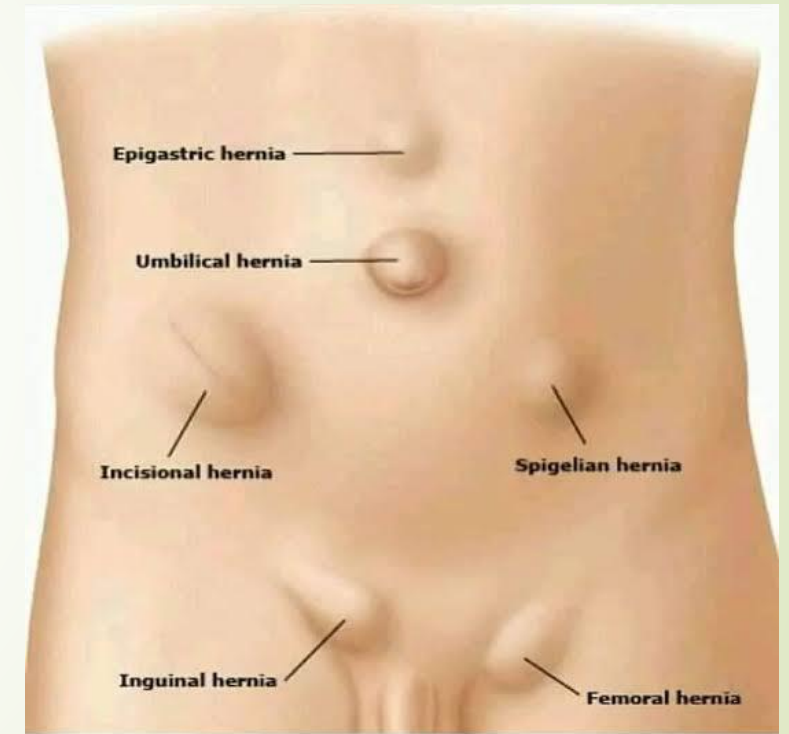


3. Rappel anatomique :

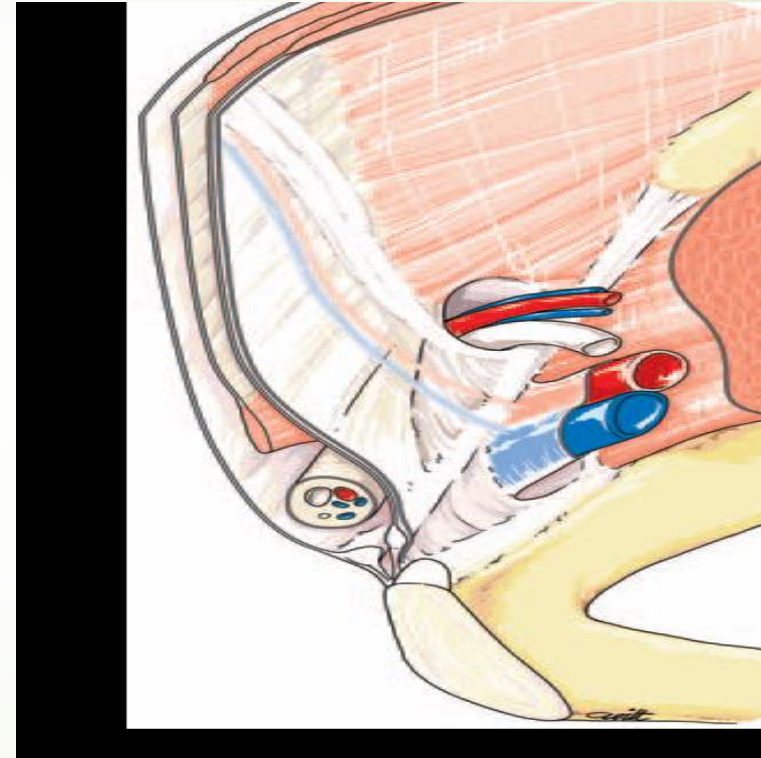
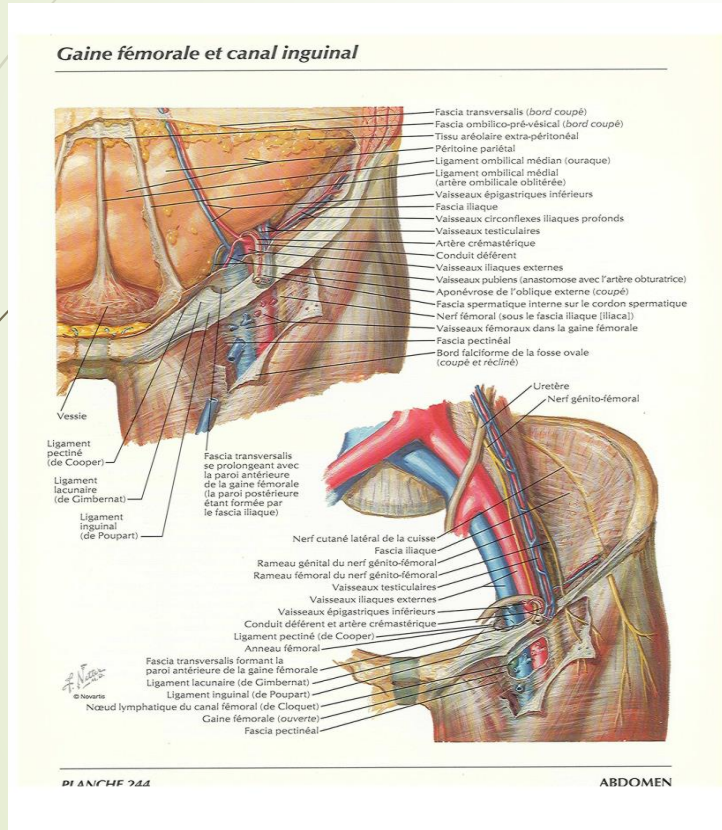
L'aïne désigne la region inguino-crurale qui est une zone de transition entre l'abdomen , la cuisse et les organes génitaux externes , donnant passage au pédicule femoral et genital .

Au niveau de l'aïne , les muscles de la paroi abdominale s'interrompent pour livrer passage à ces deux pédicules , créant une faille naturelle : l'orifice Musculo-pectinéal de Fruchaud .

Le fascia transversalis est le seul element essentiel assurant la resistance de l'abdomen au niveau de l'aïne .



3. Rappel anatomique :



4. Physiopathologie :

Les facteurs qui favorisent l'apparition d'une hernie de la paroi abdominale correspondent aux facteurs entraînant une augmentation de la pression intra- abdominale augmentant la pression au niveau de l'orifice herniaire, tel que:

- Facteurs broncho-respiratoires : bronchite chronique, toux chronique (tabac)
- Facteurs urologiques : un adénome prostatique peut entraîner une dysurie lors d'efforts mictionnels répétés.
- Facteurs digestifs : des troubles digestifs liés à un obstacle essentiellement colique ou rectal peuvent être responsables de la survenue de hernies.
- Port de charge lourde , l'âge , l'obésité , multiparité et dénutrition par faiblesse de la paroi

.

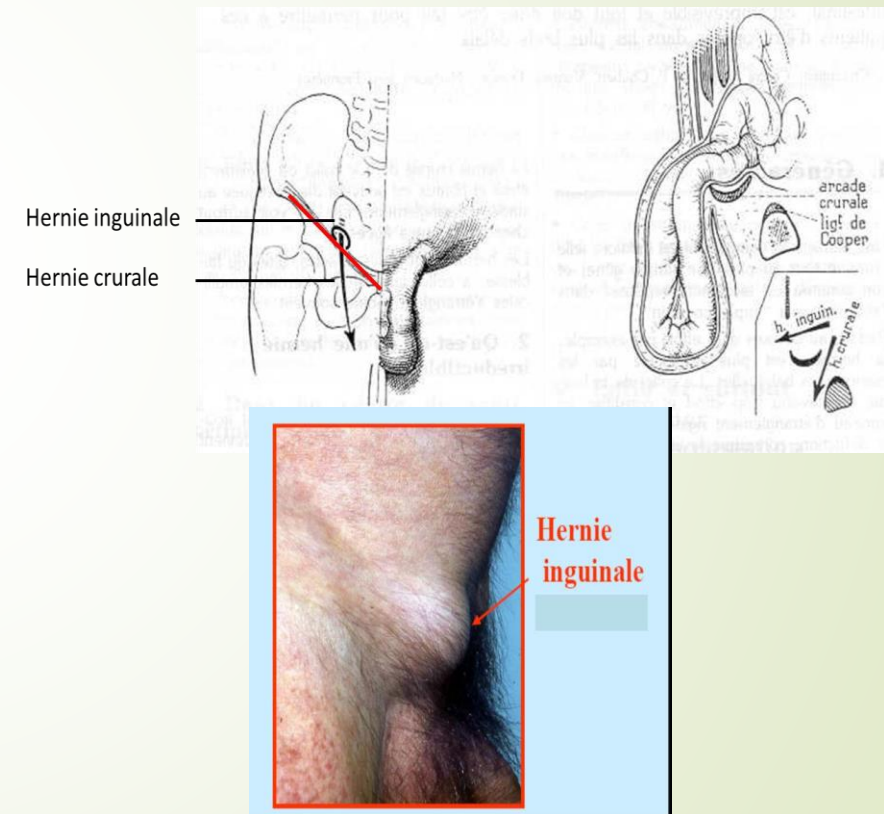
5. Siege topographique des hernies :

A. La hernie inguinale :

La région de l'aine est le siège privilégié des hernies .

Le Collet e s t situé au dessus de la ligne de Malgaigne (arcade crurale).

- Hernie indirecte: encore appelée latérale, la plus fréquente et souvent congénitale ,suit le trajet du cordon spermatique à travers l'orifice inguinal profond en dehors des vaisseaux épigastriques = H. Oblique externe. Le sac herniaire peut dépasser l'orifice inguinal superficiel et atteindre le scrotum : hernie inguino-scrotale .
-
-

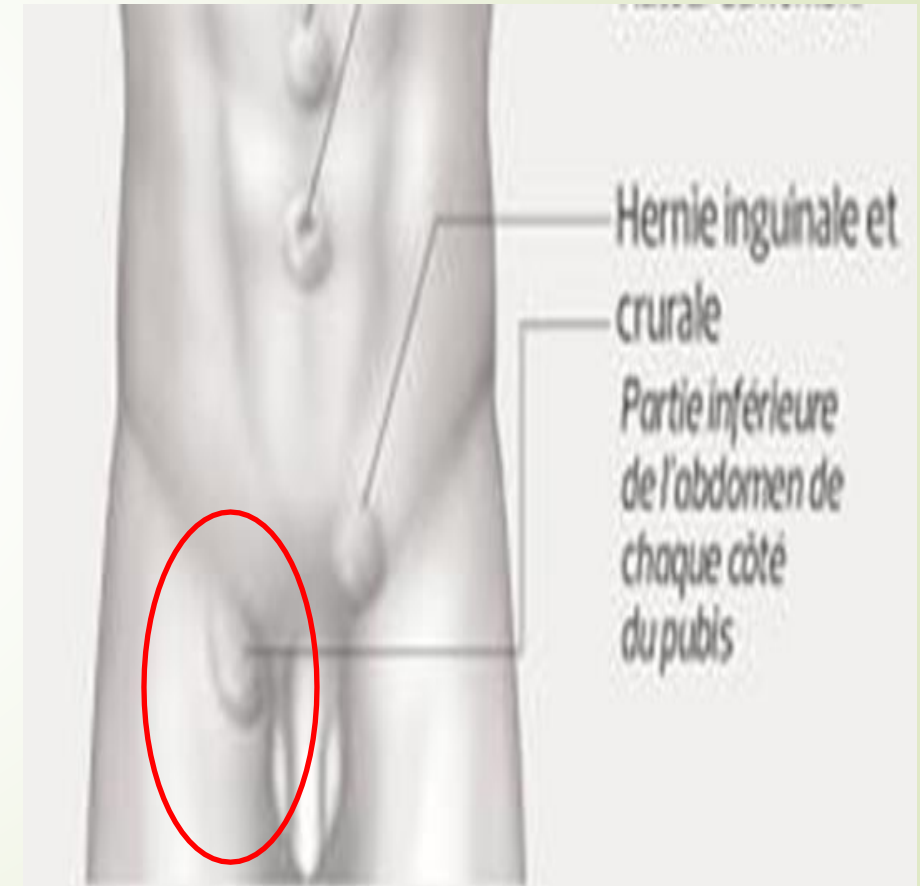


5. Siege topographique des hernies :

Hernie crurale:

le passage du sac herniaire sous l'arcade crurale

risque accru d'étranglement



C. Hernie ombilicale :

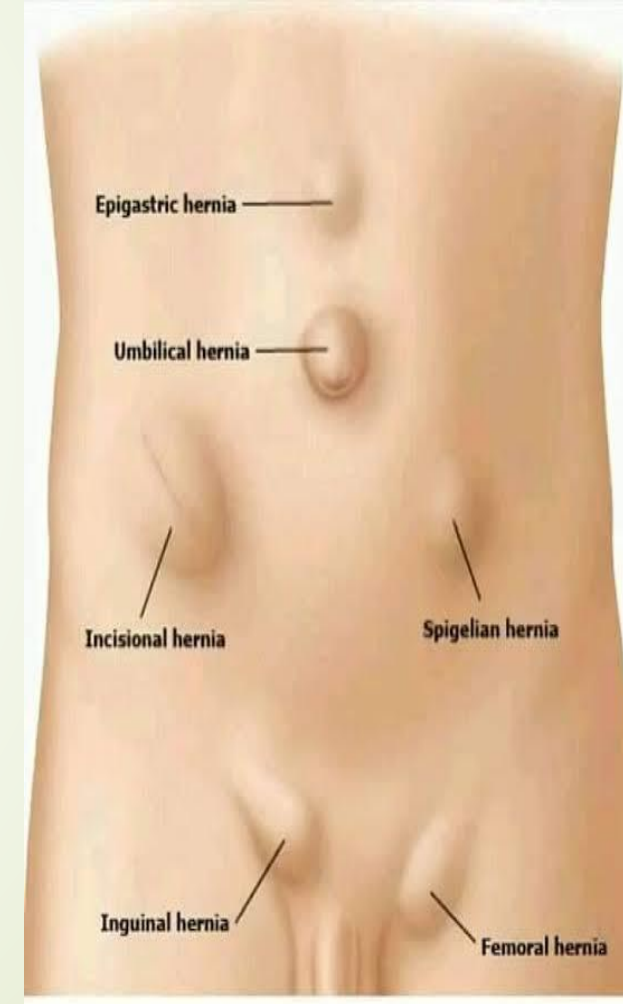
La troisième localisation , se voit chez le nouveau né , le cirrhotique et la femme obèse , limitée par l'anneau fibreux ombilical .



D. Hernie de la ligne blanche:

1- Hernie épigastrique: c'est une hernie de faiblesse, elle se situe sur la ligne blanche médiane entre l'appendice xiphoïde et l'ombilic. Le collet est étroit, inextensible, la présence d'un sac est rare du fait d'un tissu graisseux sous-péritonéal.

2- Hernie hypogastrique : c'est une hernie de faiblesse se situe sur la ligne blanche au dessous de l'ombilic.



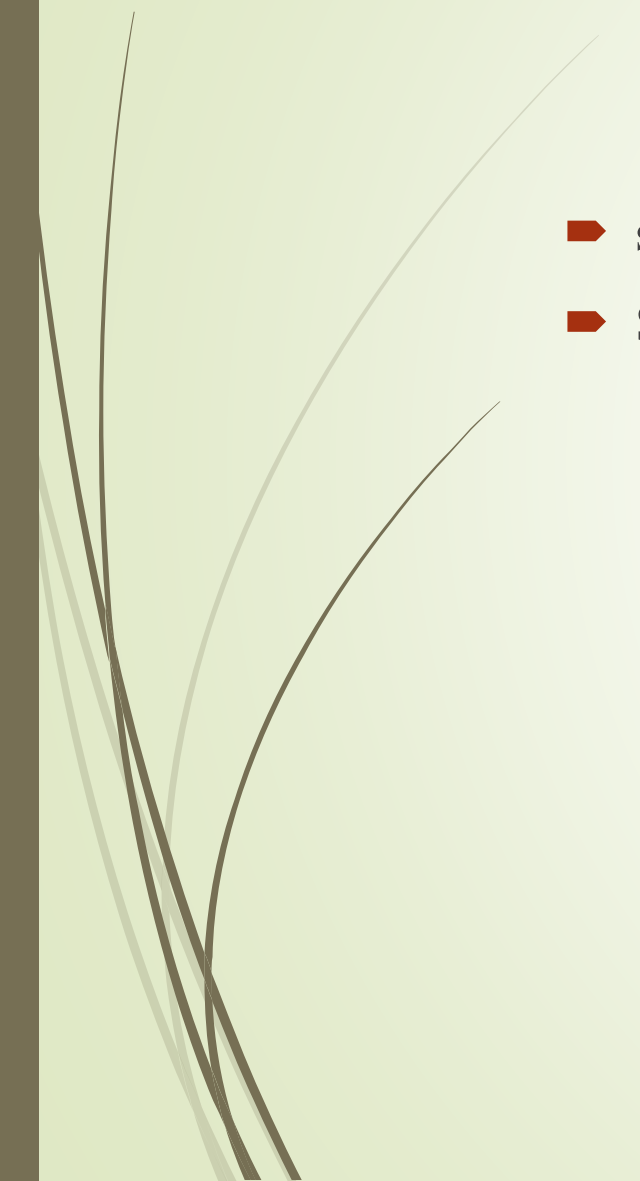
E. Les hernies rares :

sont des hernies laterale

- Hernie de Spiegel: hernie ventro latérale entre grand droit et muscle large
- Hernie obturatrice: hernie pelvienne a travers le foramen obturé non accessible à l'examen clinique
- Hernie de Jean Louis Petit: Hernie latérale entre les muscles larges



E. Eventration (hernie incisionnelle ou cicatricielle)

- suite à une laparotomie ou d'une coelio-chirurgie
 - Se voit précocement ou tardivement après cure chirurgicale.
- 

6. Diagnostic :

A. Interrogatoire :

- Date et modalités d'apparition:

Douloureuse au cours d'un effort

Récidive

- Troubles fonctionnels: Simple gêne, pesanteur , douleur à l'effort obligation de porter un bandage ,troubles digestifs ,retentissement sur l'activité physique et professionnelle
- Conditions de vie : Sujet inactif, sédentaire



B. L'examen clinique :

L'examen local : comparatif et bilatéral

- Se fait sur un patient debout puis couché en le laissant tousser
- Inspection : parfois la tuméfaction est évidente et on appréciera son volume et son caractère impulsif à la toux, étudier la peau en regard de la hernie; examiner les bourses chez l'homme
- Palpation : rechercher les repères anatomiques de la région .

Examen du canal inguinal :

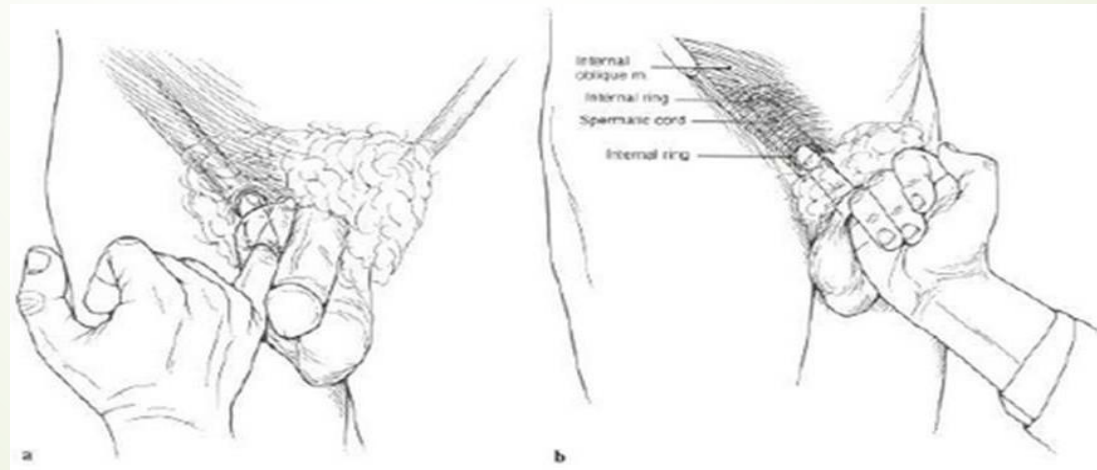
Le doigt pénètre coiffé du scrotum de l'orifice inguinal externe; on y recherche l'impulsion à la toux.

Le doigt pénètre ensuite dans l'abdomen au travers de l'orifice profond .

Manœuvre du doigt ganté de la peau scrotale :

La hernie est indirecte si elle est perçue au bout du doigt

La hernie est directe si elle est perçue en dedans du doigt



7. Diagnostic différentiel :

Hernie inguinale :

- Lipome inguinal
- Adénite inguinale.
- Ectopie testiculaire.
- Kyste du cordon.
- Hydrocèle vaginale.
- Hernie crurale.
- Varicocèle .

Hernie crurale :

- Crosse de la saphène interne
- Anévrisme fémoral
- Ganglions
- Lipome
- Adénite crurale

8. Complications :

- Étranglement : c'est la première complication, correspond à la constriction serrée et permanente d'un viscère à l'intérieur de son sac herniaire. Le contenu de sac est habituellement épiploïque, ou viscéral. évoluant vers l'ischémie et la perforation. Ces complications nécessitent l'intervention chirurgicale en urgence,

9. Traitement :

- Le traitement est chirurgical, le principe est le même pour toutes les hernies:
- Réintégration du contenu herniaire , et le traitement de la déhiscence pariétale par suture ou par mise en place de prothèse,

Hernies inguinales:

A - Les Herniorraphies:

- BASSINI : abaissement du plan musculofacial et l'arcade crurale en un seul plan par des points séparés; le tendon conjoint à l'arcade crurale avec suture du fascia transversalis.
- MAC VAY: abaissement du tendon conjoint au ligament de COOPER avec incision de décharges sur l'aponévrose du grand droit.
- SHOULDICE: suture en paletots utilisant les mêmes éléments anatomiques.



B- Les plasties sans tension (tension - free) :

Le terme de plastie sans tension a été décrite par Lischinstein pour décrire une hernioplastie sans véritable réparation de l'orifice herniaire; elle utilise un matériel prothétique et s'appuie sur de la fibrose.

La réfection par voie laparoscopique transabdominale de la hernie par la mise en place d'une prothèse .

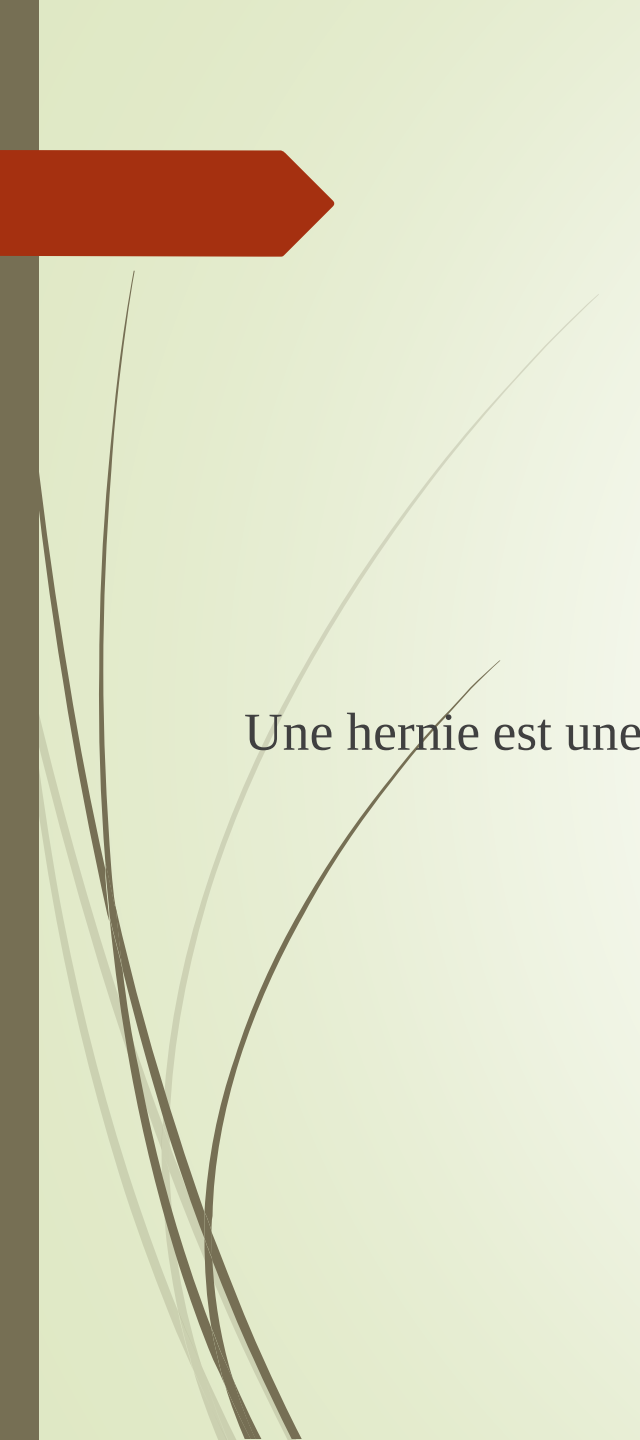


Traitement de la hernie étranglée :

- La hernie étranglée est une urgence chirurgicale , le malade doit etre opéré en urgence

objectifs :

- traiter le contenu du sac herniaire (réintégration, résection)
- réparer et refermer l'orifice herniaire



10. Conclusion :

Une hernie est une **affection bénigne** néanmoins, il faut en envisager la **cure chirurgicale** car son évolution peut être émaillée de complications redoutables.